TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
12ª VARA CÍVEL
AV. FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, 300, Campinas - SP - CEP 13088-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:	**1047882-50.2024.8.26.0114**
Classe - Assunto	**Procedimento Comum Cível - Espécies de Contratos**
Requerente:	**Bento Nogueira Sato**
Requerido:	**Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico**

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **João Luis Monteiro Piassi**

Vistos.

Trata-se de processo em trâmite pelo rito comum proposto por Bento Nogueira Sato, menor representado por sua genitor, contra Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico.

Na inicial, alega-se que: i) o autor é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte, e apresenta sintomas que não foram controlados por terapias convencionais; ii) houve prescrição médica especializada para o uso do medicamento "Cr Wellness 6000MG, tintura full spectrum", na dosagem de 28 gotas, três vezes ao dia (fl. 32); iii) a operadora ré negou a cobertura do fármaco sob o argumento de que este não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e possui caráter experimental. Pede-se: i) a condenação da ré ao fornecimento integral do medicamento conforme prescrição médica; e ii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A tutela de urgência foi inicialmente indeferida (fls. 51/52), todavia, sobreveio decisão em sede de agravo de instrumento (fls. 277/282) que concedeu a medida antecipatória para determinar o fornecimento imediato da medicação.

Regularmente citada (fl. 78), a ré apresentou contestação (fls. 79/94) sustentando, em síntese: i) a ausência de obrigatoriedade de cobertura por se tratar de medicamento de uso domiciliar e fora do rol da ANS; ii) a inexistência de dever de indenizar por ter agido no exercício regular de direito fundamentado em cláusulas contratuais.

Réplica às fls. 207/219.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
12ª VARA CÍVEL
AV. FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, 300, Campinas - SP - CEP 13088-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

Instadas a especificar provas (fl. 258), a ré manifestou-se às fls. 261/262 requerendo a expedição de ofício à ANS, já a parte autora, por sua vez, manifestou-se às fls. 263/265 protestando pela produção de prova oral, prova pericial e expedição de ofício ao NATJUS, sem prejuízo do julgamento antecipado se entenda pela suficiência documental.

O Ministério Público apresentou parecer final às fls. 285/296, opinando pela parcial procedência da ação para confirmar a tutela e fixar danos morais.

É o relatório.

Decido.

A relação travada entre as partes se rege pelo CDC, pois há prestação de serviço a destinatário final (art. 2º do CDC).

Os documentos acostados ao processo fazem verossímeis as alegações da parte autora. Por essa razão, inverto o ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Não é o caso de designar audiência de conciliação, pois as partes não manifestaram interesse em composição.

Indefiro a produção de outras provas, pois as questões controvertidas são unicamente de direito ou solucionáveis por simples prova documental, cuja apresentação está preclusa (art. 434 do CPC).

Sendo assim, cabe julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.

O art. 35 da Lei nº 9.656/1998 estabelece que:

> *Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1º de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*

O contrato em tela foi celebrado pelas partes após 01/01/1999 (fls. 155/192). Por isso, aplica-se a Lei nº 9.656/1998 ao caso.

O art. 16, VII, b, da Lei nº 9.656/1998 prevê a possibilidade de contratação de plano de saúde pelos regimes individual, familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.

> *Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *[...]*
>
> *VII - o regime, ou tipo de contratação: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *a) **individual** ou **familiar**; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *b) **coletivo empresarial**; ou (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *c) **coletivo por adesão**; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> (grifos acrescidos)

Há diferença, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016), sendo cada um regido por normas específicas, que não se aplicam a regime diverso (EDcl no REsp 602397/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 18/06/2007, p. 254).

No mais, a Lei nº 9.656/1998 é regulamentada por atos da Agência Nacional de Saúde, conforme previsão do art. 1º, § 1º do referido diploma:

> *Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *[...]*
>
> *§ 1º Está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *a) custeio de despesas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
12ª VARA CÍVEL
AV. FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, 300, Campinas - SP - CEP 13088-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

> *c) reembolso de despesas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *d) mecanismos de regulação; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *e) qualquer restrição contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *f) vinculação de cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-assistenciais. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*

O contrato em tela é do tipo individual/familiar e possui registro na ANS sob nº 408.592/99-2 (fls. 155/192).

Estabelecem o art. 10, caput, V e VI, § 6º, e o art. 12, I, c, II, g, § 5º, da Lei nº 9.656/1998:

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *[...]*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*
>
> *[...]*
>
> *§ 6º As coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades, observado o disposto no § 7º deste artigo*
>
> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *[...]*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
12ª VARA CÍVEL
AV. FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, 300, Campinas - SP - CEP 13088-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

[...]

II - quando incluir internação hospitalar:

[...]

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

[...]

§ 5º O fornecimento previsto nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput deste artigo dar-se-á em até 10 (dez) dias após a prescrição médica, por meio de rede própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, sendo obrigatória a comprovação de que o paciente ou seu representante legal recebeu as devidas orientações sobre o uso, a conservação e o eventual descarte do medicamento.

A matéria é regulamentada pela Resolução Normativa ANS nº 465/2021:

Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.º 9.656, de 1998.

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

[...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.

> *período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para:*
>
> *[...]*
>
> *IX - quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos medicamentos para o tratamento do câncer com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de saúde;*
>
> *X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características:*
>
> *a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido pela Lei n.º 9.787/1999; e*
>
> *b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do órgão competente, esta atualmente a cargo da ANVISA.*

A validade e aplicabilidade de tais limites é pacífica no STJ:

> *AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INSULINA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, ADQUIRIDO EM FARMÁCIA COMUM. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.*
>
> *1. Como bem ponderado pela Corte local, "a bomba infusora de insulina é aparelho que pode ser facilmente adquirido em farmácias", sendo, pois, tecnicamente medicamento de uso domiciliar. Com efeito, como assentado pela Terceira Turma, é "lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)"*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.

(REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)

2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital" (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021). Portanto, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos/aplicados comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

3. Por um lado, como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos. Por outro lado, a saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.973.853/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.

> *os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).*
>
> *4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.*
>
> *5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.*
>
> *6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.*
>
> *7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).*
>
> *8. Recurso especial provido.*
>
> *(REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)*

Contudo, a interpretação restritiva outrora adotada pelo C. STJ deve ser agora analisada à luz das recentes alterações legislativas e da proteção especial conferida à pessoa com deficiência.

Com efeito, a superveniência da Lei nº 14.454/2022 alterou substancialmente a Lei nº 9.656/1998, estabelecendo a natureza exemplificativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Vejamos:

> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo [ANS], a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.

Segundo o novo regramento, se o tratamento ou medicamento prescrito pelo médico assistente não estiver previsto no rol, a cobertura será obrigatória desde que: i) exista comprovação da eficácia, à luz da medicina baseada em evidências; ou ii) existam recomendações de órgãos de renome nacional ou internacional.

No caso dos autos, a necessidade do fármaco à base de *cannabis* medicinal está sobejamente demonstrada pelo relatório médico de fl. 32, que atesta o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 e a falha de tratamentos convencionais. Note-se que a própria ANVISA, por meio da Resolução RDC nº 660/2022, autoriza e regulamenta a importação desses produtos para fins terapêuticos, o que supre o requisito de evidência científica e segurança sanitária.

Ademais, tratando-se de beneficiário com TEA, a negativa de cobertura afronta a Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), que garante o atendimento multiprofissional e o acesso a ações e serviços de saúde, inclusive medicamentos.

Nesse contexto, a exclusão de cobertura sob o pretexto de ser medicamento "domiciliar" ou "fora do rol" revela-se abusiva. Se a doença está coberta pelo contrato, a escolha da melhor terapia cabe ao médico assistente e não à operadora.

A recusa injustificada, portanto, fere a boa-fé objetiva e a função social do contrato, colocando em risco o próprio objeto da avença, que é a preservação da saúde e da dignidade do menor.

Noutro giro, a resistência da operadora em fornecer o tratamento essencial para o desenvolvimento de uma criança autista extrapola o mero descumprimento contratual. A angústia e o sofrimento impostos à família, que se viu obrigada a recorrer ao Judiciário para garantir o básico à saúde do menor, configuram dano moral.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos envolvendo menores com TEA e negativa de cannabis medicinal:

> *APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer Pretensão de compelir a empresa ré a custear o medicamento prescrito para o tratamento de autismo e de deficiência intelectual grave que acomete o autor - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando que não pode ser compelida a*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.

> *arcar com os custos de medicamentos à base de canabidiol que não consta no rol taxativo da ANS, acrescentando que o medicamento não possui registro na Anvisa, além de ser de caráter experimental, sendo descabida a condenação ao pagamento de danos morais - Caso em que incumbe ao médico que acompanha o paciente, e não ao plano de saúde, determinar qual o tratamento, medicamento ou equipamento utilizado para a solução da moléstia, de modo que,* ***havendo prescrição médica e sendo a moléstia abrangida pelo contrato, a recusa da ré é ilegal*** *- Irrelevante a existência ou não de previsão do procedimento no rol da ANS para cobertura pelo plano de saúde, em razão dos avanços da medicina -* ***É inadmissível a negativa de fornecimento de medicamento derivado de "cannabis", devidamente autorizado pela ANVISA - Negativa de cobertura do plano que ofende o direito à vida e gera o direito aos danos morais pleiteados, mantidos em R$ 10.000,00 - Precedentes desta Câmara - Recurso desprovido.*** *(TJSP; Apelação Cível 1013144-25.2022.8.26.0011; Relator (a): José Aparicio Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2023; Data de Registro: 09/10/2023) (grifos acrescidos)*

> *APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE - Ação julgada procedente para condenar a apelante 1) ao fornecimento do medicamento canabidiol Healthmeds (60ml, 600mg; 100mg/ml), 24 vidros/ano, até alta médica definitiva; e 2) ao pagamento de indenização extrapatrimonial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Insurgência da operadora. Descabimento. Paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista grave (TEA - CID-10 F84.9), transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH - CID-10 F90) e características ansiosas (CID-10 F41.9). Necessidade incontroversa da administração do fármaco. Prescrição médica indicando o tratamento - Alteração da Lei nº 9.656/98 pela Lei nº 14.454 de 21 de setembro de 2022. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar que constitui referência básica para os planos de saúde. Cobertura que deverá ser autorizada se comprovada a eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ('rol exemplificativo'). Incidência da Súmula nº 102 deste E. Tribunal. Precedentes deste E. Tribunal Bandeirante e desta C. Câmara -* ***Dano moral reconhecido. Arbitramento que deve observar a intensidade da culpa do agente, as consequências do ato ilícito e o grau de hipossuficiência do consumidor. Ponderação entre o caráter pedagógico da indenização e a vedação de enriquecimento ilícito. Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara. Razoável e proporcional a fixação do quantum em R$ 10.000,00 (dez mil reais).*** *Sentença mantida - Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004068-17.2021.8.26.0009; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2023; Data de Registro: 26/06/2023) (grifos acrescidos)*

Para a fixação da indenização pelos danos morais (art. 944 do CC), considero os seguintes fatores: a) a natureza do bem jurídico lesado (saúde e integridade psicofísica de criança com Transtorno do Espectro Autista - TEA); b) a resistência injustificada na cobertura de fármaco essencial prescrito por médico assistente, agravando a angústia da unidade familiar; c) a

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
12ª VARA CÍVEL
AV. FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, 300, Campinas - SP - CEP 13088-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

capacidade econômica das partes. Dados esses elementos, e em consonância com o parecer ministerial (fls. 285/296), fixo a indenização em R$ 10.000,00, valor adequado à espécie e à função punitivo-pedagógica da condenação.

O art. 1º da Lei n 6.899/1981 estabelece que a correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios. Será contada da data desta sentença, quando de seu arbitramento (Súmula 362 do STJ). Calcula-se pelos índices da Tabela Prática do TJSP.

Os juros de mora são contados da citação, nos termos do art. 405 do CC (AgInt no AREsp 869.645/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016), de acordo com as seguintes taxas: (i) 0,5% ao mês até 10/01/2003 (art. 1.062 do CC/1916); (ii) SELIC entre 11/01/2003 e 29/08/2024 (arts. 397, 406 e 2.024 do CC/2002, antes da alteração pela Lei nº 14.905/2024, conforme Tema 1368 do STJ); (iii) diferença entre a taxa Selic e o IPCA (ou índice de correção convencionado), mas nunca inferior a 0 (art. 406 do CC/2002, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, em vigor a partir de 30/08/2024).

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para:

i) condenar a ré a fornecer ao autor o medicamento "Cr Wellness 6000MG, tintura full spectrum", conforme a prescrição de fl. 32 (28 gotas, 3 vezes ao dia), enquanto perdurar a necessidade médica, ficando a continuidade do fornecimento condicionada à apresentação, pelo autor, de relatório médico atualizado a cada 12 (doze) meses; e

ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação.

Confirma o tutela de urgência anteriormente deferida (fls. 277/282).

Condeno a parte ré ao pagamento:

a) das despesas processuais (atualizadas do desembolso; art. 1º da Lei nº 6.899/1981);

b) de honorários advocatícios aos patronos da parte autora, que fixo em 10% do valor da condenação de pagar quantia certa.

Passados 30 dias do trânsito em julgado, arquivem-se definitivamente os autos, independentemente de nova intimação das partes. Eventual pedido de cumprimento de sentença forçado (art. 523 do CPC) ou voluntário (art. 526 do CPC) deve ser deduzido por incidente, na

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
12ª VARA CÍVEL
AV. FRANCISCO XAVIER DE ARRUDA CAMARGO, 300, Campinas - SP - CEP 13088-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

forma dos arts. 917, caput, I, e 1.285 das Normas de Serviço da CGJ/TJSP e da Resolução CNJ nº 65/2009. A questão é expressamente tratada na cartilha "Cautelas para evitar erros frequentes: Novo MovJud" elaborada pelo E. TJSP (), da qual consta o seguinte: "Nos termos do Comunicado CG nº 1789/2017, requerido o cumprimento de sentença por peticionamento intermediário, no ato do cadastramento do pedido o sistema adotará a tramitação em apartado, com geração de numeração própria. Os futuros peticionamentos intermediários deverão ocorrer no cumprimento de sentença incidental. [...] O cumprimento de sentença não deve, em hipótese alguma, ser entranhado nos autos do processo de conhecimento, pois nesse caso não será possível registrar a informação de que o processo principal já está encerrado". Sendo assim, desde já indefiro a realização de qualquer depósito voluntário nestes autos a título de pagamento de condenação.

Por ocasião do protocolamento do incidente, em obediência ao Comunicado CG nº 438/2016 e Provimento CGJ n º 05/2019, deverá o peticionante atentar-se para:

a) No peticionamento eletrônico, acessar o menu "Petição Intermediária 1º Grau";

b) Preencher o número do processo principal;

c) O sistema completará os campos "Foro" e "Classe do Processo";

d) No campo "Categoria", selecionar o item "Execução de Sentença";

e) No campo "Tipo da Petição", selecionar o item "156 Cumprimento de Sentença" ou "157 Cumprimento Provisório de Sentença" ou "12078 Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública", conforme o caso.

Tratando-se de processo eletrônico, é obrigatória apenas a juntada do demonstrativo atualizado e discriminado do débito.

O desarquivamento dos autos dependerá de prévio recolhimento de taxa (Comunicado TJSP nº 211/2019), a menos que a parte requerente seja beneficiária da justiça gratuita.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Campinas, 19 de fevereiro de 2026.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por João Luis Monteiro Piassi, liberado nos autos em 19/02/2026 às 16:14 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047882-50.2024.8.26.0114 e código fOPdb32d.